



LAPORAN KEGIATAN KERJA SAMA 2023-2024

**UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
dengan
SMK INSAN MULIA KRAMAT KAB TEGAL**

**PROGRAM BEASISWA KERJA
(PELATIHAN BAHASA JEPANG)
PELAKSANA : UNIT HUMAS & KERJA SAMA**

**UNIT HUMAS DAN LAYANAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
Gd. Rektorat Lt. 1
Jln Cut Nyak Dien No 16 Kalisapu Slawi
bhamadahumas@gmail.com**



LAPORAN KEGIATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN SMK INSAN MULIA KRAMAT

I. DATA MITRA

Nama Mitra Kerja Sama : SMK Insan Mulia Kramat Kabupaten Tegal
Tingkat Kerja Sama : Lokal/Nasional / Internasional* (pilih salah satu)

II. DATA PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksana Kerja Sama : Unit Humas dan Kerja Sama
Bukti Kerja Sama : 009/Univ.BHAMADA/KL/V/2024

III. DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Kegiatan : Program *Teaching Factory*
Waktu Pelaksanaan : Bulan Agustus 2024
Pihak yang Terlibat : Dosen Keperawatan, Siswa Kelas XI SMK Insan Mulia Kramat

Deskripsi Kegiatan :

Kegiatan ini dilaksanakan berhubungan dengan penyelenggaraan magang guru dalam Program *Teaching Factory*. Dosen DIII Keperawatan Theodora Rosaria G, M.Kep dan Ani Ratnaningsih, M.Kep serta Dosen SI Keperawatan Eka Diana Permatasari, M.Kep menjadi guru tamu dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi kompetensi keahlian yang dikembangkan kesehatan di SMK Insan Mulia Kramat. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Jumat sebanyak pada 4 kali pertemuan yaitu pada tanggal 9 Agustus 2024, 16 Agustus 2024, 23 Agustus 2024, 6 September 2024. Materi yang disampaikan berkaitan dengan keperawatan medikal bedah diantaranya perawat luka dekubitus, perawatan luka bakar, perawatan luka bersih dan perawatan luka jahit. Kegiatan ini masuk dalam mata pelajaran P5 dan dimulai dengan penjelasan materi kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi perawatan luka. Siswa yang hadir di ikuti oleh kelas XI sejumlah ± 20 siswa.

IV. PENUTUP

Demikian laporan implementasi kerja sama antara Universitas Bhamada Slawi dengan SMK Insan Mulia Kramat Kabuten Tegal. Laporan ini dibuat sebagai bukti adanya tindak lanjut kerja sama dengan mitra.

Ka. Unit Humas dan Kerja Sama



Anisa Oktiawati, M.Kep
NIPY. 1986.10.04.11.062



LAPORAN KEGIATAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN SMK INSAN MULIA KRAMAT

V. BUKTI KEGIATAN

a. Foto Kegiatan



Foto 1 Dosen sedang menjelaskan tentang perawatan luka dekubitus



Foto 2 Dosen sedang mendemonstrasikan tentang perawatan luka dekubitus



Foto 3 Dosen sedang menjelaskan tentang perawatan luka bersih



Foto 4 Dosen sedang menjelaskan tentang perawatan luka bersih



Foto 5 Dosen sedang menjelaskan tentang perawatan luka bakar



Foto 6 Dosen sedang mendemonstrasikan tentang perawatan luka bakar



YAYASAN PENDIDIKAN TRI SANJA HUSADA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi : Ilmu Keperawatan (S1), Profesi Ners, Farmasi (S1), Keselamatan Kesehatan Kerja (D-IV), Keperawatan (DIII), Kebidanan (DIII)
Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu Telp. (0283) 6197570-6197571, Fax. (0283) 6198450 Slawi, Kab. Tegal
E-mail : fikesbhamada@gmail.com SK. MENDIKBUD RISET & TEKNOLOGI : 325/E/O/2021

SURAT TUGAS

Nomor: 063/Univ.BHAMADA/FIK/LL/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini memberikan tugas kepada :

Nama : Theodora Rosaria Geglorian, M.Kep
Jabatan : Dosen DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi
Keperluan : Program Teaching Factory
Penyelenggara : SMK Insan Mulia Kramat Kabupaten tegal
Pelaksanaan : Bulan Agustus 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Slawi

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Dekan,



[Signature]
Rosmalia, S.T., M.Kes

NIPY: 1976.11.09.02.022



YAYASAN PENDIDIKAN TRI SANJA HUSADA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi : Ilmu Keperawatan (S1), Profesi Ners, Farmasi (S1), Keselamatan Kesehatan Kerja (D-IV), Keperawatan (DIII), Kebidanan (DIII)
Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu Telp. (0283) 6197570-6197571, Fax. (0283) 6198450 Slawi, Kab. Tegal
E-mail : fikesbhamada@gmail.com SK. MENDIKBUD RISET & TEKNOLOGI : 325/E/O/2021

SURAT TUGAS

Nomor: 062/Univ.BHAMADA/FIK/LL/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini memberikan tugas kepada :

Nama : Eka Diana Permatasari, M.Kep
Jabatan : Dosen S1 Ilmu Keperawatan dan Ners
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi
Keperluan : Program Teaching Factory
Penyelenggara : SMK Insan Mulia Kramat Kabupaten Tegal
Pelaksanaan : Bulan Agustus 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Slawi

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Dekan,


Rosmaha S1, M.Kes
NIPY. 1976.11.09.02.022



YAYASAN PENDIDIKAN TRI SANJA HUSADA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Prodi : Ilmu Keperawatan (S1), Profesi Ners, Farmasi (S1), Keselamatan Kesehatan Kerja (D-IV), Keperawatan (DIII), Kebidanan (DIII)
Jl. Cut Nyak Dhien, Kalisapu Telp. (0283) 6197570-6197571, Fax. (0283) 6198450 Slawi, Kab. Tegal
E-mail : fikesbhamada@gmail.com SK. MENDIKBUD RISET & TEKNOLOGI : 325/E/O/2021

SURAT TUGAS

Nomor: 064/Univ.BHAMADA/FIK/LL/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini memberikan tugas kepada :

Nama : Ani Ratnaningsih, M.Kep
Jabatan : Dosen DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi
Keperluan : Program Teaching Factory
Penyelenggara : SMK Insan Mulia Kramat Kabupaten tegal
Pelaksanaan : Bulan Agustus 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Slawi

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Dekan,



Resmaha ST., M.Kes

NIPY. 1976.11.09.02.022

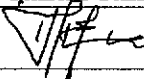
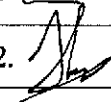
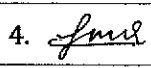
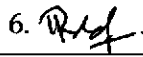
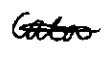
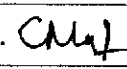
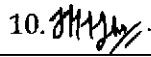
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI (P5)
"PERAWATAN DECUBITUS"

Pembicara : Ns. Theodora Rosaria Geglorian, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 9 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Adi Mustopa		1. 
2.	Ahmad Rifqi Syafii	XI ASKEP	2. 
3.	Ayu Septi Aulia Ramadhani	XI ASKEP	3. 
4.	Dinda Nur Aulia Putri	XI ASKEP	4. 
5.	Dinda Ratna Juwita	XI ASKEP	5. 
6.	Eka Prihatini Tasaufillah		6. 
7.	Erni Ayu Ardita	XI ASKEP	7. 
8.	Friska Nurul Umi	XI ASKEP	8. 
9.	Imel Nuralinsia	XI ASKEP	9. 
10.	Ismahatul Shofi Prasetyo	XI ASKEP	10. 
11.	Isnuh Elsyia Widya Kusuma	XI ASKEP	11. 
12.	Linda Putri Sri Indah	XI ASKEP	12. 
13.	Nurul Fadhilah	XI ASKEP	13. 

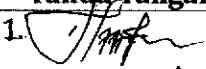
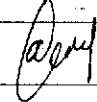
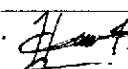
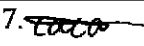
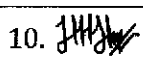
DAFTAR HADIR SISWA KELAS X (P5)
"PERAWATAN DECUBITUS"

Pembicara : Ns. Theodora Rosaria Geglorian, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 9 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Anggun Diah Permatasari		1. 
2.	Ifena Alma Monika		2. 
3.	Nur Auliyah Rizki		3. 
4.	Ines Yuli Alfariani		4. 
5.	Nur Cahya Lintang Lestari		5. 
6.	Ryana Zahra Aulia		6. 
7.	Messya Silvyani		7. 
8.	Nina Cahyani		8. 
9.	Wiranti Aulia		9. 
10.	Alifia Nurul Aeni		10. 

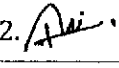
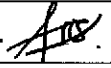
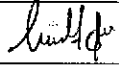
DAFTAR HADIR SISWA KELAS X (TEACHING FACTORY)
"PERAWATAN LUKA BERSIH"

Pembicara : Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Anggun Diah Permatasari	X	1. 
2.	Ifena Alma Monika	X	2. 
3.	Nur Auliyah Rizki		3. 
4.	Ines Yuli Alfariani	X	4. 
5.	Nur Cahya Lintang Lestari	X	5. 
6.	Ryana Zahra Aulia		6. 
7.	Messya Silvyani	X	7. 
8.	Nina Cahyani		8. 
9.	Wiranti Aulia	X	9. 
10.	Alifia Nurul Aeni	X	10. 

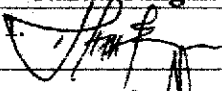
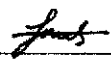
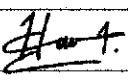
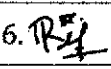
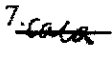
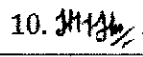
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI (P5)
"PERAWATAN LUKA BERSIH"

Pembicara : Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Adi Mustopa		1. 
2.	Ahmad Rifqi Syafii		2. 
3.	Ayu Septi Aulia Ramadhani		3. 
4.	Dinda Nur Aulia Putri		4. 
5.	Dinda Ratna Juwita		5. 
6.	Eka Prihatini Tasaufillah		6. 
7.	Erni Ayu Ardita		7. 
8.	Friska Nurul Umi		8. 
9.	Imel Nuralinsia		9. 
10.	Ismahatul Shofi Prasetyo		10. 
11.	Isnuh Elsyia Widya Kusuma		11. 
12.	Linda Putri Sri Indah		12. 
13.	Nurul Fadhilah		13. 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS X (TEACHING FACTORY)
"PERAWATAN LUKA BAKAR"

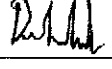
Pembicara : Ani Ratnaningsih, M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Anggun Diah Permatasari	X	
2.	Ifena Alma Monika	X	2. 
3.	Nur Auliyah Rizki	X	3. 
4.	Ines Yuli Alfariani	X	4. 
5.	Nur Cahya Lintang Lestari	X	5. 
6.	Ryana Zahra Aulia	X	6. 
7.	Messya Silvyani	X	7. 
8.	Nina Cahyani	X	8. 
9.	Wiranti Aulia	X	9. 
10.	Alifia Nurul Aeni	X	10. 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI (TEACHING FACTORY)
"PERAWATAN LUKA BAKAR"

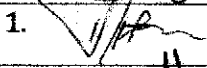
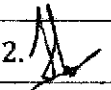
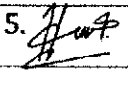
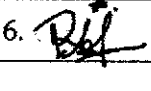
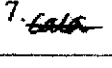
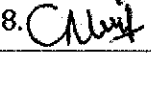
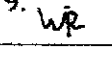
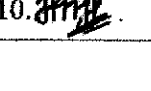
Pembicara : Ani Ratnaningsih, M.Kep

Hari, tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Adi Mustopa	XI	1. 
2.	Ahmad Rifqi Syafii	XI	2. 
3.	Ayu Septi Aulia Ramadhani	XI	3. 
4.	Dinda Nur Aulia Putri	XI	4. 
5.	Dinda Ratna Juwita	XI	5. 
6.	Eka Prihatini Tasaufillah	XI	6. 
7.	Erni Ayu Ardita	XI	7. 
8.	Friska Nurul Umi	XI	8. 
9.	Imel Nuralinsia	XI	9. 
10.	Ismahatul Shofi Prasetyo	XI	10. 
11.	Isnuh Elsyia Widya Kusuma	XI	11. 
12.	Linda Putri Sri Indah	XI	12. 
13.	Nurul Fadhilah	XI	13. 

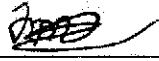
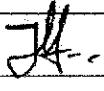
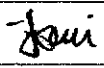
DAFTAR HADIR SISWA KELAS X (TEACHING FACTORY)
"PERAWATAN LUKA JAHIT"

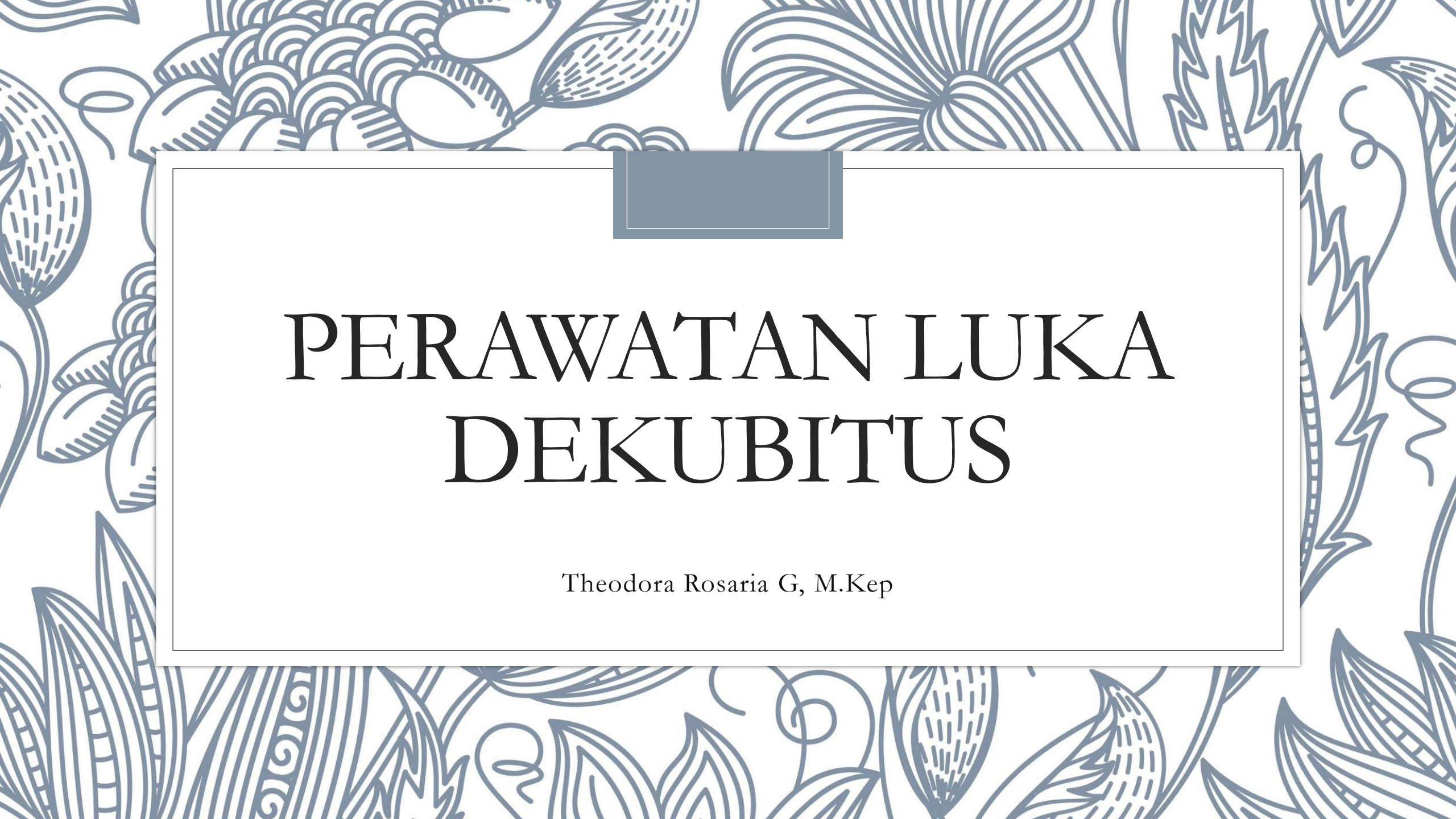
Pembicara : Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 6 SEPTEMBER 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Anggun Diah Permatasari		1. 
2.	Ifena Alma Monika		2. 
3.	Nur Auliyah Rizki		3. 
4.	Ines Yuli Alfariani		4. 
5.	Nur Cahya Lintang Lestari		5. 
6.	Ryana Zahra Aulia		6. 
7.	Messya Silvyani		7. 
8.	Nina Cahyani		8. 
9.	Wiranti Aulia		9. 
10.	Alifia Nurul Aeni		10. 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI (P5)
"PERAWATAN LUKA JAHIT"

Pembicara : Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep., M.Kep
Hari, tanggal : Jumat, 6 September 2024

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1.	Adi Mustopa		1. 
2.	Ahmad Rifqi Syafii		2. 
3.	Ayu Septi Aulia Ramadhani		3. 
4.	Dinda Nur Aulia Putri		4. 
5.	Dinda Ratna Juwita		5. 
6.	Eka Prihatini Tasaufillah		6. 
7.	Erni Ayu Ardita		7. 
8.	Friska Nurul Humt ISMI		8. 
9.	Imel Nuralinsia		9. 
10.	Ismahatul Shofi Prasetyo		10. 
11.	Isnuh Elsy Widya Kusuma		11. 
12.	Linda Putri Sri Indah		12. 
13.	Nurul Fadhillah		13. 



PERAWATAN LUKA DEKUBITUS

Theodora Rosaria G, M.Kep

Apa yang akan kita pelajari?



TEORI PERAWATAN
LUKA DEKUBITUS



PRAKTIKUM PERAWATAN
LUKA DEKUBITUS

Definisi

- **Luka adalah hilang/rusaknya jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam / tumpul yang sengaja / tidak disengaja , baik terbuka / tertutup. bersih / terkontaminasi dan superficial / dalam.**
- **Dekubitus adalah luka yang terjadi akibat penekanan pada area tulang-tulang yang menonjol karena pasien dalam keadaan bedrest yang lama.**

Sering terjadi pada:

- **Pasien yang sangat kurus/ malnutrisi/anemia**
- **Pasien lansia**
- **Pasien kegemukan**
- **Pasien dengan tirah baring lama , koma, stroke, cedera**
- **Pasien dengan DM**
- **Pada luka bakar bisa terjadi dengan pasien dengan derajat 2-3 tergantung luas dan daerah yang terkena luka bakar**

Etiologi

Ekstrinsik

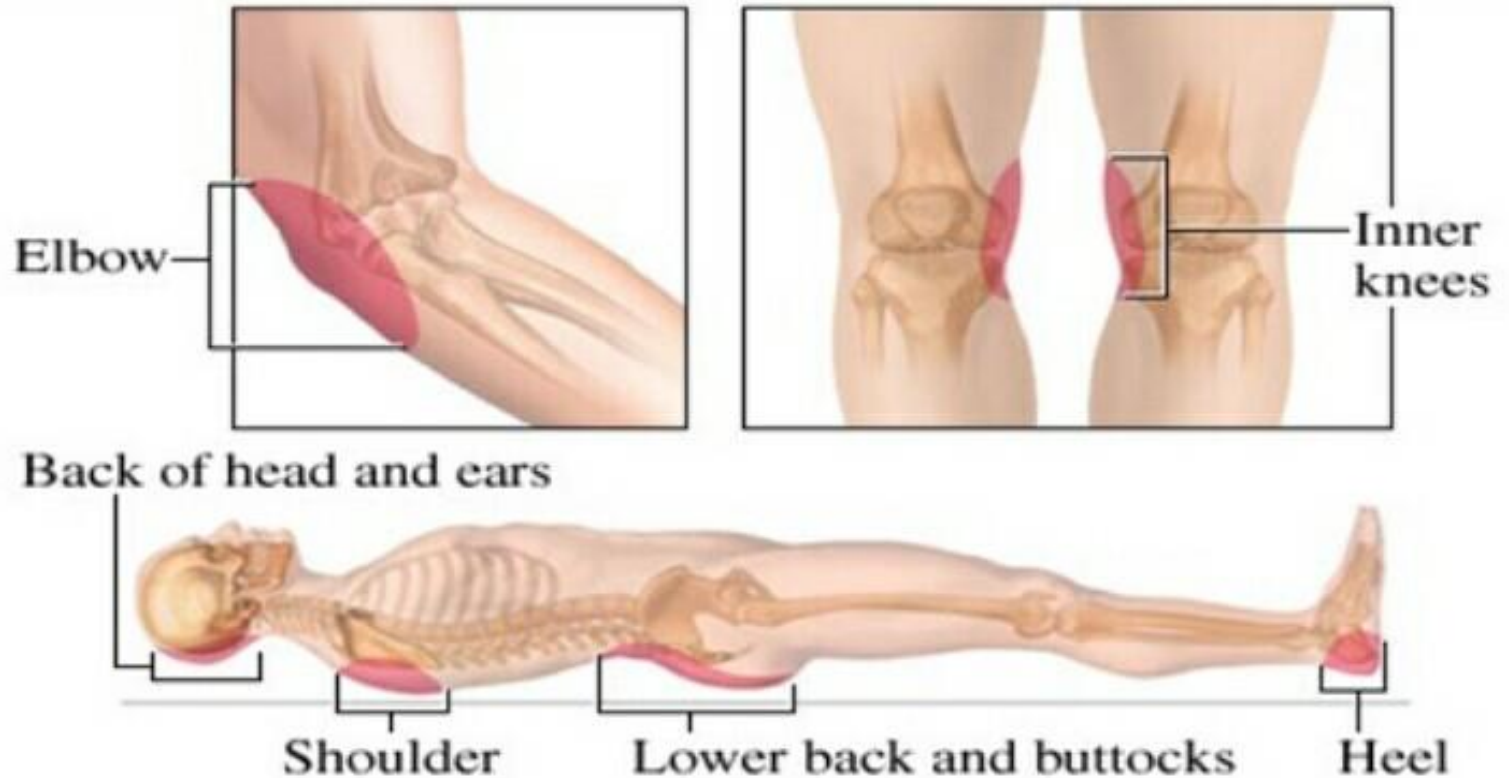
1. Tekanan
2. Gesekan atau pergeseran
3. Kelembapan
4. Kebersihan tempat tidur

Intrinsik

1. Usia
2. Ggn syaraf vasomotorik, sensorik, dan motoric
3. Malnutrisi/ anemia
4. Penurunan kesadaran
5. Infeksi
6. Merokok
7. Temperetur kulit
8. Hipoalbumin
9. Penyakit kardiovaskuler, penyait pembuluh darah,dll

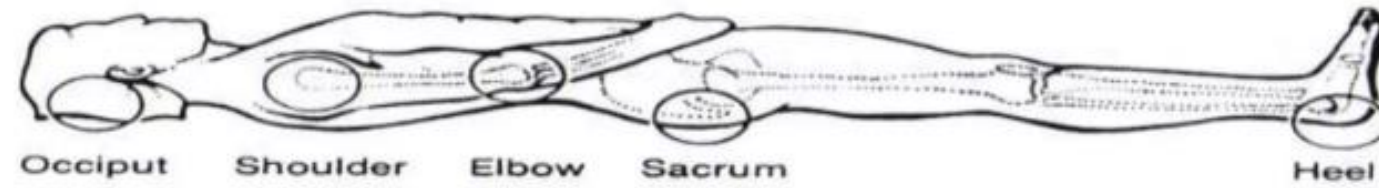
Manifestasi klinis

1. Edema
2. Kerusakan otot
3. Kerusakan jaringan kulit

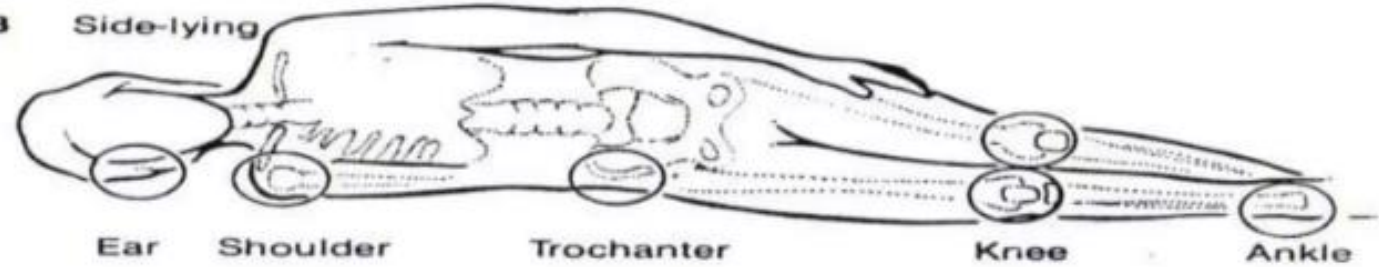


- a. Pada penderita pada posisi terlentang: pada daerah belakang kepala, daerah tulang belikat, daerah bokong dan tumit.
 - b. Pada penderita dengan posisi miring: daerah pinggir kepala (terutama daun telinga), bahu, siku, daerah pangkal paha, kulit pergelangan kaki dan bagian atas jari-jari kaki.
 - c. Pada penderita dengan posisi tengkurap: dahi, lengan atas, tulang iga, dan lutut.
-

A Supine



B Side-lying



C Sitting

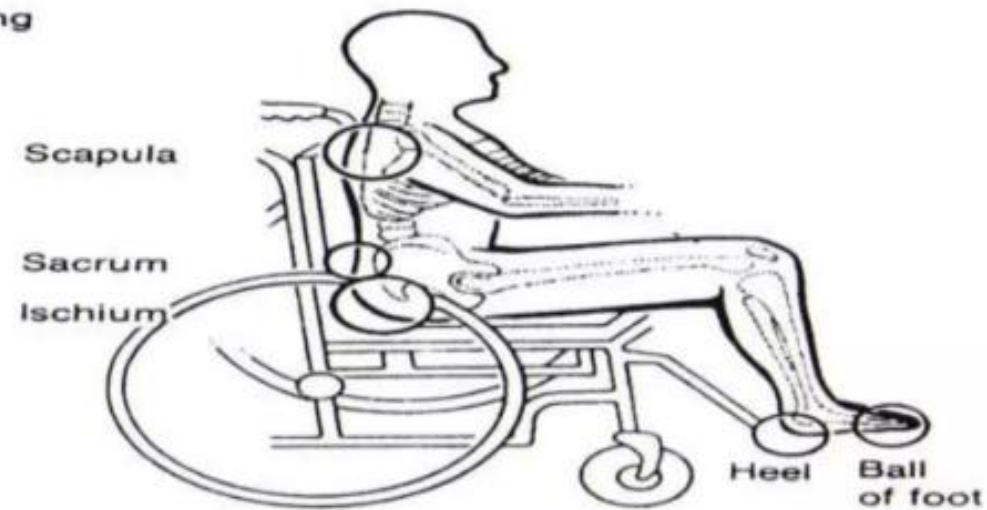


Figure 15-1. Typical locations of pressure ulcers.

Derajat 1: reaksi peradangan terbatas pada epidermis.

Derajat 2: hilang sebagian /seluruh epidermis, ada luka superficial, abrasi, melepuh, dan membentuk lubang dangkal.

Derajat 3: hilang lapisan kulit lengkap, adanya nekrosis jaringan subcutan ke dalam dan tampak luka yang dalam.

Derajat 4: terdapat nekrosis jaringan lengkap, otot tulang dan tendon.

Tahap 1



- Memerah
- Belum menjadi luka
- Tidak berubah menjadi cerah saat disentuh

Tahap 2



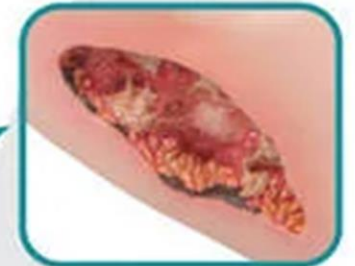
- Kulit rusak
- Luka seperti kawah yang dangkal

Tahap 3

- Luka berbentuk keruh dalam
- Timbul nanah
- Jaringan rusak

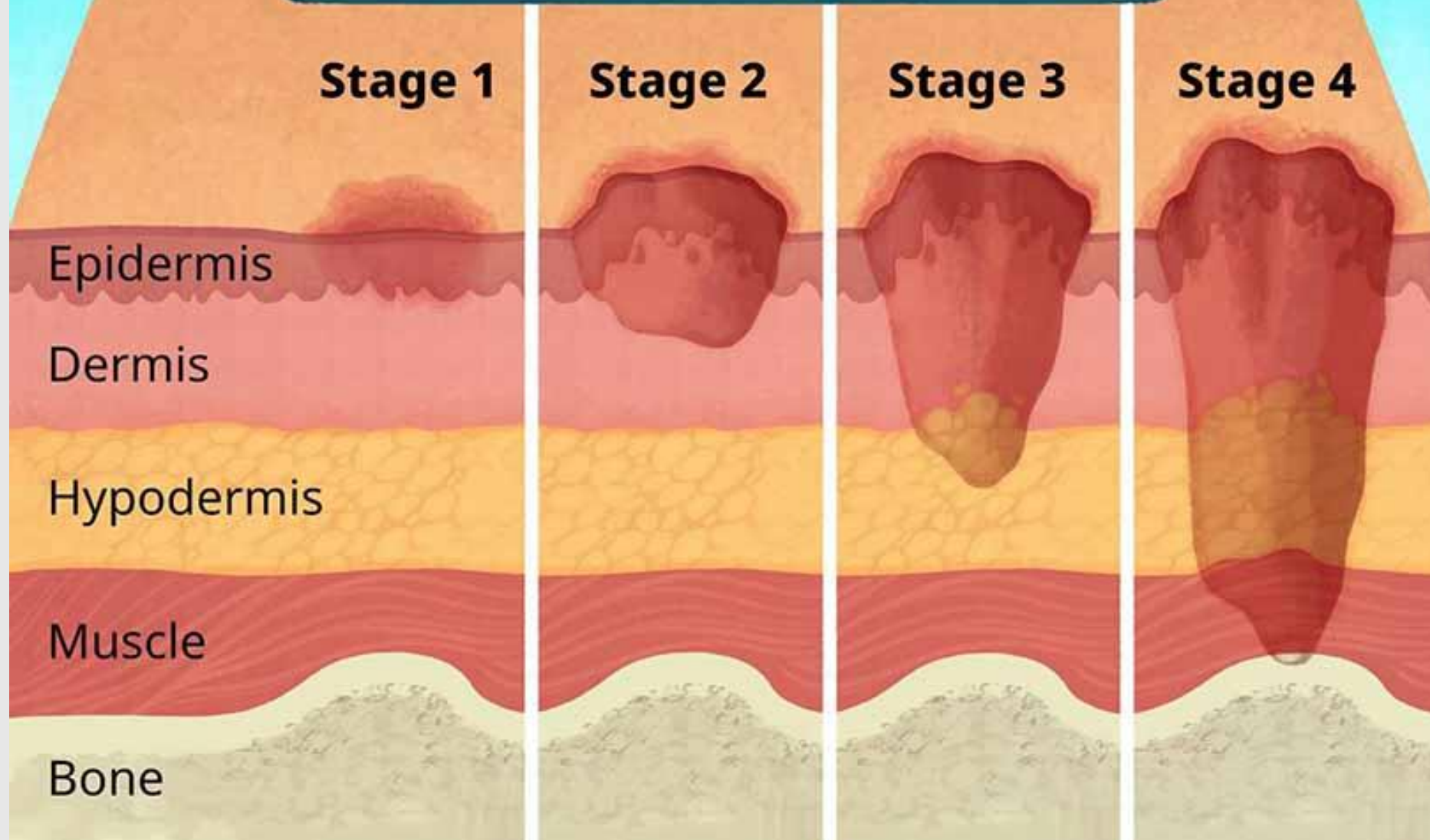


Tahap 4



- Kulit rusak parah
- Muncul luka yang besar
- kadang tulang, otot, atau tendon terlihat
- Ada jaringan mati berwarna hitam (eschar)

Stages of a Pressure Ulcer





mediset
products

DEKUBITUS GRAD I



mediset
products

DEKUBITUS GRAD II

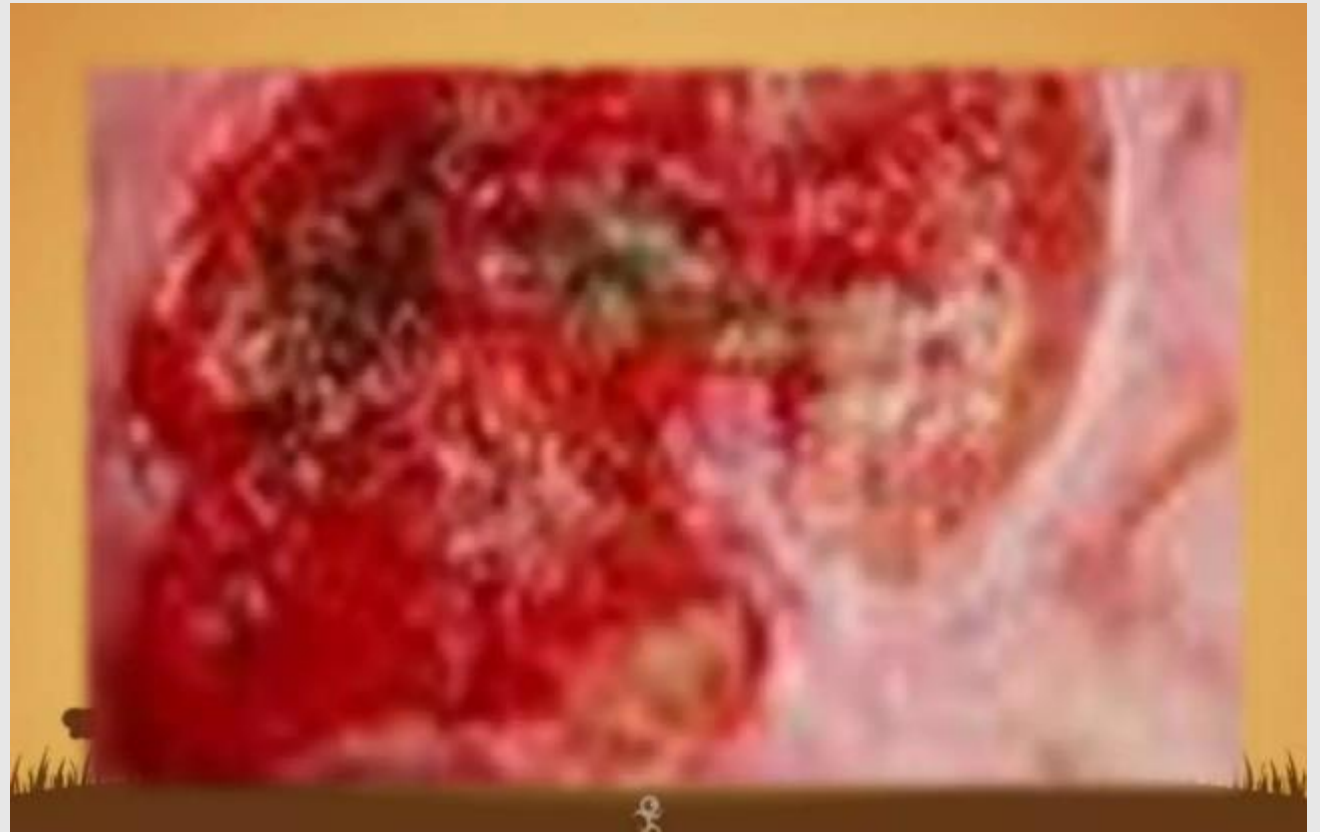


DEKUBITUS GRAD III



DEKUBITUS GRAD IV

Jaringan Nekrosis





Perawatan Luka Dekubitus

A. Persiapan Peralatan

1. Set steril, terdiri atas

- a. Kapas alcohol
- b. Kassa steril
- c. Baki untuk larutan NaCl 0,9%
- d. Pinset anatomis
- e. Pinset chirurgis
- f. Lidi kapas steril

2. Derian tube/cutimed sorbact

3. Gunting plester

4. Perekat

5. Alkohol 70%

6. Larutan NaCl 0,9%

7. Handschoon bersih

8. Handschoon steril

9. Penggaris milimeter disposable

10. Pencahayaan

Pra Interaksi

1. Lakukan verifikasi program terapi
2. Cuci tangan
3. Dekatkan alat ke pasien

Orientasi

1. Mengucapkan salam
2. Memperkenalkan diri
3. Mengidentifikasi pasien minimal 2 identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan / atau nomor rekam medis)
4. Menjelaskan tujuan tindakan
5. Menjelaskan langkah prosedur
6. Menanyakan kesiapan pasien
7. Menjaga *privacy* pasien

Kerja

- 1. Pakai sarung tangan bersih**
- 2. Monitor karakteristik luka (meliputi: drainase, warna, ukuran dan bau)**
- 3. Monitor tanda-tanda infeksi (calor, dolor, rubor, tumor dan functiolaesa)**
- 4. Lepaskan balutan dan plester secara perlahan**
- 5. Lepaskan sarung tangan bersih dan pasang sarung tangan steril**
- 6. Bersihkan luka dengan cairan NaCl atau pembersih *nontoxic*, sesuai kebutuhan**

Kerja

- 7. Lakukan palpasi pada luka**
- 8. Bersihkan jaringan nekrotik, *jika ada***
- 9. Bersihkan luka dengan cairan NaCl lagi**
- 10. Berikan salep yang sesuai dengan kondisi luka, *jika perlu***
- 11. Pasang balutan sesuai jenis luka**

Kerja

- 12. Anjurkan konsumsi makanan tinggi kalori dan protein**
- 13. Ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri**
- 14. Anjurkan untuk mobilisasi (miring kanan, terlentang, kiri setiap 2 jam)**
- 15. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan**
- 16. Letakkan di troli yang disediakan**
- 17. Lepaskan sarung tangan**

Terminasi

- 1. Melakukan evaluasi tindakan**
- 2. Merapikan alat**
- 3. Berpamitan**
- 4. Mencuci tangan**
- 5. Dokumentasi tindakan**

Penampilan Selama Tindakan

- 1. Ketenangan selama melakukan tindakan**
- 2. Melakukan komunikasi terapeutik selama tindakan**
- 3. Ketelitian dan keamanan pasien selama tindakan**

Terima Kasih

Soal

1. Apa yang disebut dengan decubitus?
2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri grade pada luka decubitus!
3. Bagaimana cara perawatan luka pada decubitus?



PERAWATAN LUKA BAKAR

Ani Ratnaningsih



Luka bakar
tingkat pertama

Luka bakar
tingkat kedua

Luka bakar
tingkat ketiga





- Luka bakar adalah sebuah trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam

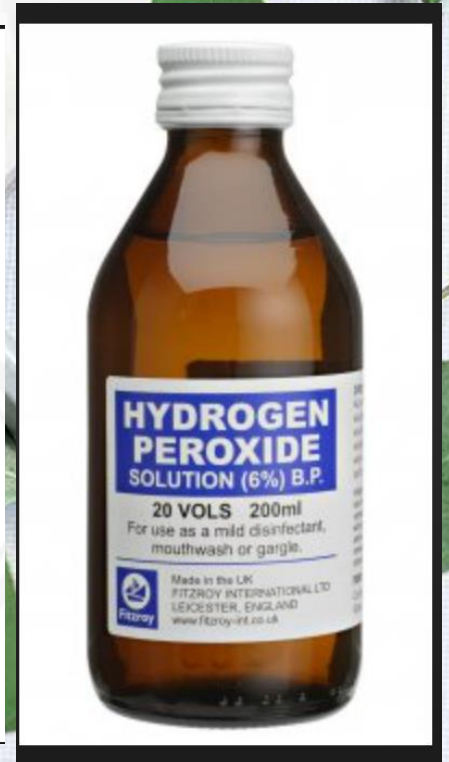
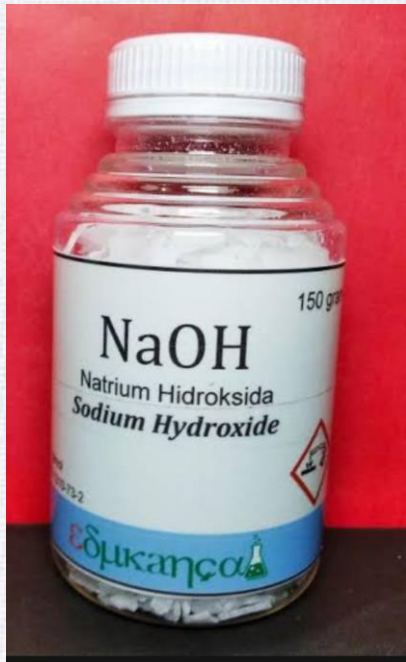
	Korosif	Asam dan Basa Kuat	Korosif artinya bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan.
	Beracun/ toksik	Merkuri, sianida	Beracun artinya suatu zat yang dapat menimbulkan kecelakaan, penderitaan, ataupun kematian apabila tertelan, terhirup, atau terserap melalui kulit.
	Iritasi/ berbahaya	Kloroform	Iritasi artinya bahan-bahan yang umumnya tidak korosif tetapi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan apabila bersentuhan dengan kulit atau bagian tubuh lainnya sehingga dapat menimbulkan hilangnya pigmen atau melepuh.
	Radioaktif	Uranium, plutonium	Bahan radioaktif artinya bahan-bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi dapat mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau lama.
	Mudah meledak	Campuran hidrogen dan oksigen.	Mudah meledak/eksplotif artinya bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, atau kontak dengan api.

Bahan kimia yang dapat menyebabkan luka bakar

Jenis	Penjelasan	Contoh
Asam	Zat korosif yang dapat menyebabkan luka bakar parah saat kontak karena memecahkan protein dan menghancurkan jaringan. Asam umumnya digunakan di berbagai industri seperti manufaktur, pembersihan, dan laboratorium.	Asam sulfat Asam klorida Asam nitrat
Alkali	Alkali atau basa adalah kelompok bahan kimia yang dapat menyebabkan luka bakar karena menyebabkan kerusakan jaringan. Alkali sering ditemukan dalam produk pembersih, pembersih saluran pembuangan, dan pelarut industri. Alkali dapat menyebabkan kerusakan jaringan dalam dan sangat berbahaya ketika mereka bersentuhan dengan mata.	Natrium hidroksida (soda kaustik), kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida
Pelarut	Pelarut adalah zat yang dapat melarutkan zat lain. Beberapa pelarut dapat menyebabkan luka bakar ketika bersentuhan dengan kulit. Bahan kimia ini dapat menghilangkan minyak pelindung dari kulit, menyebabkan kekeringan, kemerahan, dan dalam kasus yang parah, luka bakar.	bensin, aseton, dan pengencer cat,

Bahan kimia yang dapat menyebabkan luka bakar.....

Jenis	Penjelasan	Contoh
Pengoksidasi	Pengoksidasi adalah bahan kimia yang meningkatkan pembakaran dan dapat menyebabkan luka bakar ketika bereaksi dengan bahan yang mudah terbakar. Bahan kimia ini biasanya digunakan dalam desinfektan, pemutih, dan produk pembersih kolam renang. Ketika oksidator bersentuhan dengan kulit, mereka dapat menyebabkan luka bakar kimia dan iritasi.	hidrogen peroksida, klorin, dan kalium permanganat
Iritasi	Iritasi tertentu masih dapat menyebabkan luka bakar dan kerusakan pada kulit. Paparan yang terlalu lama terhadap iritasi ini dapat menyebabkan kulit terbakar, kemerahan, dan peradangan.	Deterjen kuat, amonia, dan beberapa bahan pembersih.



Derajat kedalaman luka

1. Luka bakar derajat 1
2. Luka bakar derajat 2
3. Luka bakar derajat 3
4. Luka bakar derajat 4



Derajat I		▪ Luka bakar terbatas di epidermis, cth: luka sengatan matahari ▪ Luka disertai eritema, nyeri tanpa timbul lepuh ▪ Penyembuhan spontan 3 – 4 hari dan tidak menimbulkan jaringan parut
Derajat II superfisial		▪ Kerusakan meluas sampai ke lapisan dermis, organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea masih utuh ▪ Dasar luka berwarna merah atau pucat, sering terletak lebih tinggi di atas kulit normal ▪ Penyembuhannya spontan waktu 10-14 hari,
Derajat II dalam		▪ Luka bakar ini meliputi dekstruksi epidermis dan dermis yang menimbulkan lepuh dan edema (ringa-sedang) dengan rasa nyeri. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea sebagian besar masih utuh ▪ Penyembuhan terjadi lebih lama tergantung epitel yang tersisa, biasanya 1 bln, terkadang dilakukan operasi penambalan kulit

Derajat III



- Kerusakan meluas ke jaringan sub kutis, pembuluh kapiler dan vena mungkin hangus dan aliran darah ke daerah tersebut berkurang serta syaraf rusak
- Orang kulit seperti folike rambut, kel keringat, kel sebasea mengalami kerusakan
- Kulit yang terbakar berwarna abu abu dan pucat. Letak lebih rendah dari kulit sekitar
- Penyembuhan terjadi lama karena tidak ada proses epitelisasi spontan dari dasar luka

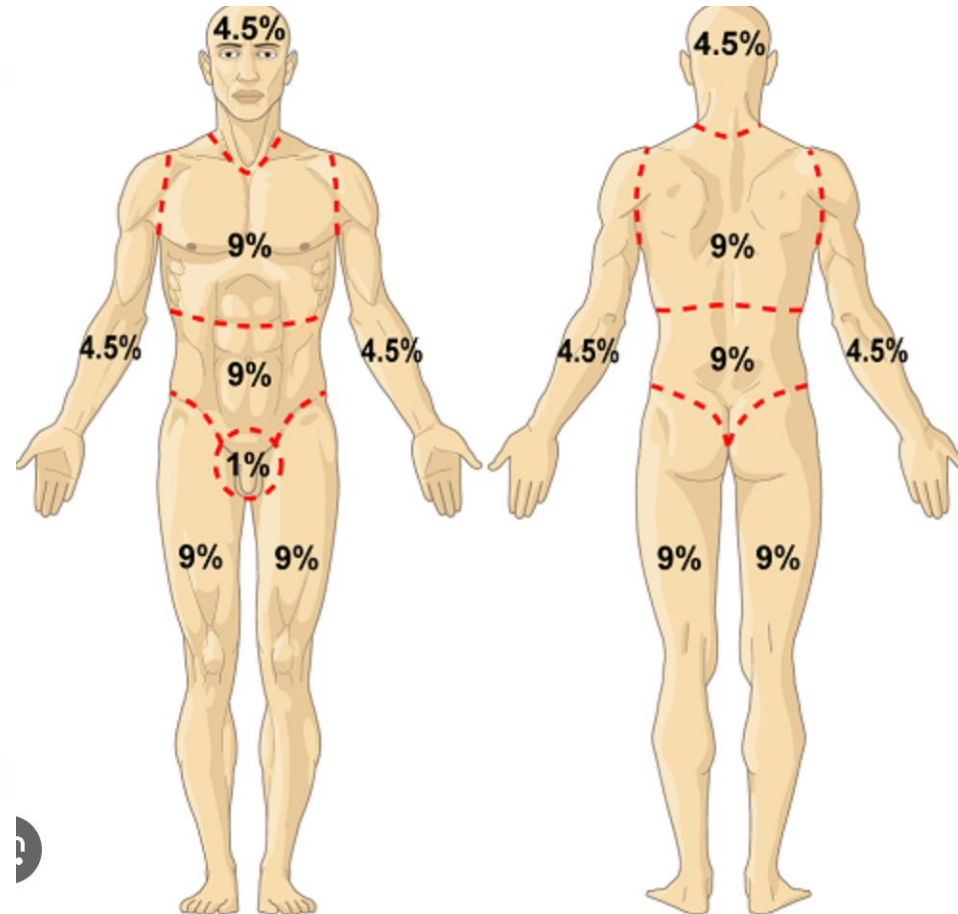
Derajat IV



- Kerusakan meluas melalui jaringan subcutan hingga mengenai otot dan tulang

LUAS LUKA BAKAR

- Pedoman untuk memperkirakan luas daerah yang terbakar dapat dilakukan dengan hukum sembilan (*rule of nine*)



Klasifikasi luka bakar berdasarkan derajat dan luasnya kulit

Luka bakar ringan	• Luka bakar derajat 1 sebesar $<15\%$ • Luka bakar derajat 2 sebesar $<2\%$
Luka bakar sedang	▪ luka bakar derajat 1 sebesar 10-15% ▪ Luka bakar derajat 2 sebesar 5-10%
Luka bakar berat	▪ Luka bakar derajat 2 sebesar $> 20\%$ ▪ Luka bakar derajat 3 sebesar $> 10\%$ ▪ Luka bakar yang mengenai wajah, tangan, kaki, alat kelamin, persendia, sekitar ketiak ▪ Luka bakar akibat sengatan listrik tegangan tinggi ($>1000\text{ V}$) ▪ Luka bakar dengan komplikasi patah tulang ▪ Luka bakar dengan kerusakan jaringan lunak ▪ Luka bakar dengan gangguan jalan nafas

PERAWATAN PADA LUKA BAKAR

Penanganan luka bakar derajat 1 dan 2 saat di tempat kejadian

1. Alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia alirkan air terus menerus selama 20 menit atau lebih.
2. Lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting pakaian di sekitarnya yang tidak menempel, dan jangan memaksa untuk melepaskannya.
3. Tutup luka bakar, gunakan penutup luka steril, dan jangan memecahkan gelembung.
4. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, kopi, air es.
5. Segera rujuk ke fasilitas kesehatan.



Rujuk ke pusat pelayanan kesehatan segera jika:

- Luka menembus semua bagian kulit (luka bakar derajat 3)
- Luka bakar luas
- Kulit tampak hangus dengan bercak putih, coklat atau hitam
- Bagian yang terbakar adalah tangan, kaki, wajah atau alat kelamin
- Korban adalah lansia, bayi atau balita



Perawatan luka bakar

Prinsip perawatan luka bakar:

1. Menghentikan proses pembakaran dengan menjauhkan dari sumber
2. Mendinginkan luka dengan air mengalir
3. Memberikan obat anti nyeri
4. Melepas cincin atau benda ketat di area tubuh yang terbakar
5. Tutup luka bakar dengan perban steril
6. Oleskan salep pada luka bakar

Balutan luka bakar

1. Dangkal – film dressing
2. Dalam –kassa paraffin atau salep anti microbial
- 3.

DAFTAR PUSTAKA



- Ross A. Moore, et al. (2024). National Library of Medicine. Rule of Nines. Diakses tanggal 15 Agustus 2024 melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513287>
- RS Kasih Ibu Surakarta. Luka Bakar dan Pertolongan Pertamanya. Diakses tanggal 15 Agustus 2024 melalui <https://rskasihibu.com/2019/01/28/luka-bakar-dan-pertolongan-pertamanya/>
- Haryono, R & Utami, P. (2019). Keperawatan Medikal Bedah. Bantul: Joglo Aksara

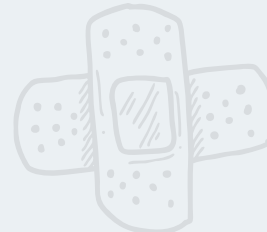
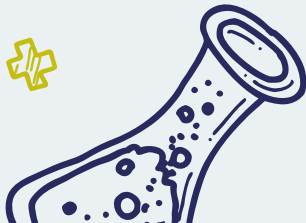
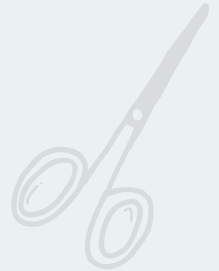
The background of the slide is a dense, repeating pattern of watercolor-style green leaves and branches. The leaves are in various shades of green, from light lime to deep forest green, and are scattered across the entire frame. In the center, there is a thin, light orange rectangular border.

THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation

Perawatan Luka Bersih

Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep., M.Kep.





CV



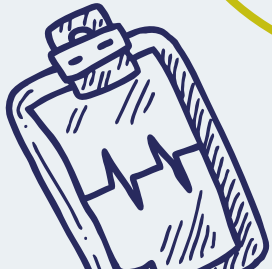
**Ns. Eka Diana Permatasari, S.Kep.,
M.Kep**

Dosen Program Studi Ilmu
Keperawatan dan Ners Universitas
Bhamada Slawi, Peminatan
Keperawatan Medikal Bedah

S1 Universitas Diponegoro
Profesi Ners Universitas Diponegoro
S2 Universitas Diponegoro



TTL: Cilacap, 7 Oktober 1996
Alamat: Jl Wijaya Kusuma Gang 14
Kudaile, Slawi





Luka Jahit



Luka Bakar

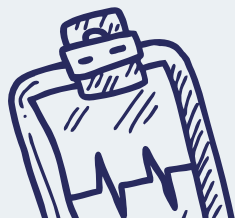


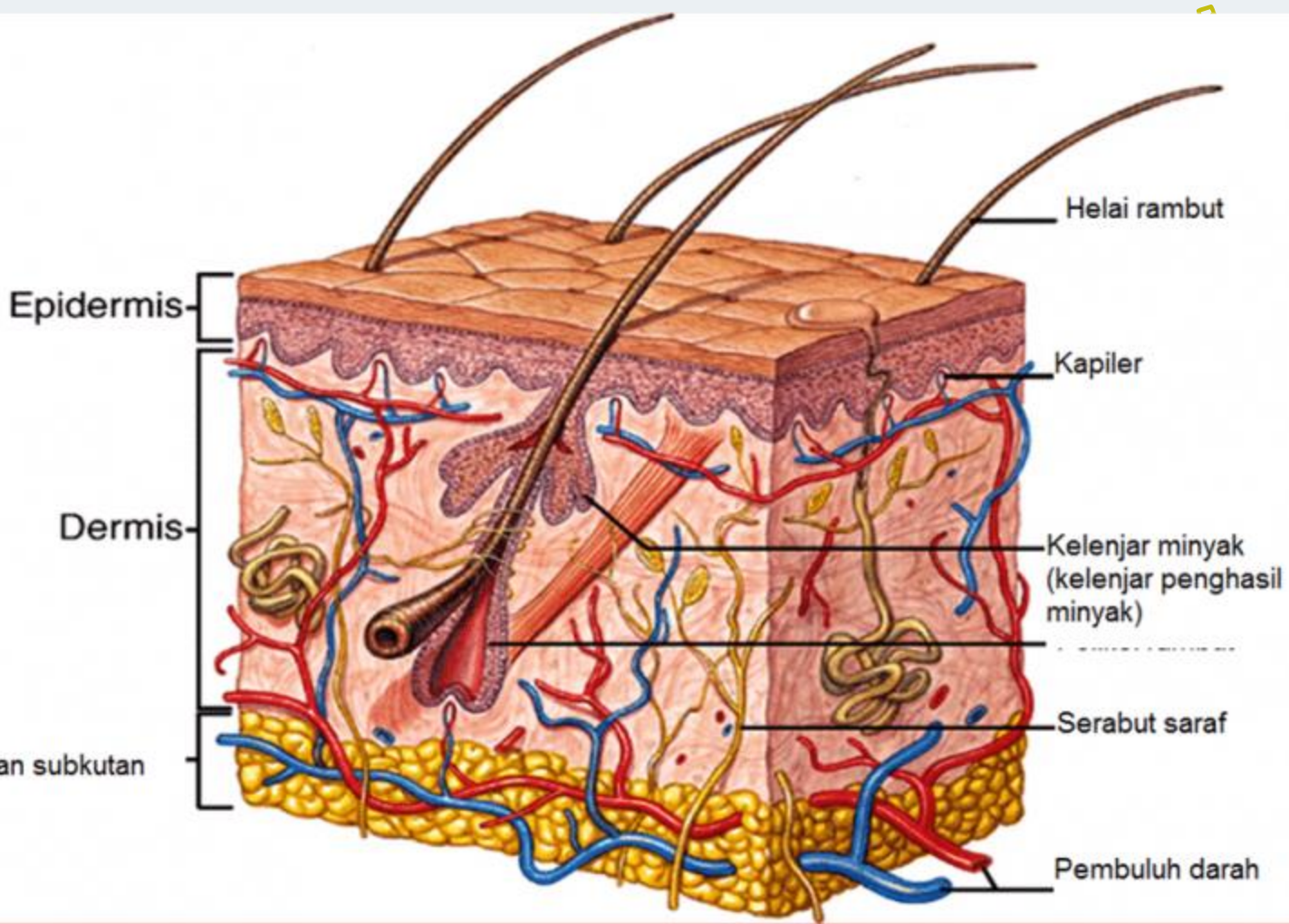


Luka Lecet



Luka Diabetes





Luka?

Cidera pada kulit yang mengalami robek, teriris, tertusuk, atau memar (ketika terkena benda tumpul)

Kondisi **terputusnya jaringan lunak** seperti saraf, otot, kulit, atau pembuluh darah



Penyebab Luka



Trauma Mekanis

Akibat benda tumpul atau tajam



Luka Tusukan

Akibat benda tajam yang menusuk kulit



Luka Tekan

Luka karena penekanan yang lama



Gigitan

Gigitan manusia atau gigitan hewan



Luka Lecet

Luka karena terpotong atau laserasi

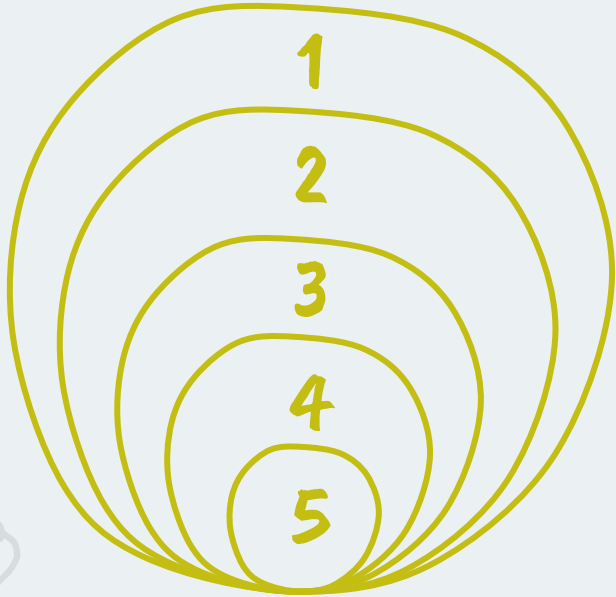


Luka Bakar

Akibat terkena benda yang bersifat membakar



Jenis Luka



1 Luka lecet (Abrasi)

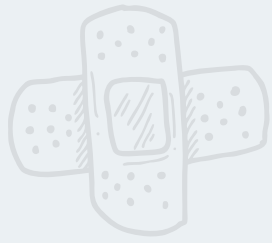
3 Luka
Tusukan

5 Luka Jahit

2 Luka Robek
(Lacerasi)

4 Luka Bakar





Berdasarkan Waktu Penyembuhan Luka

Luka Kronis

Penyembuhan 2-3 mgg

Contoh:

Ulkus diabetik, ulkus
dekubitus



Luka Akut

Penyembuhan 4-6 mgg

Contoh:

Luka pascaoperasi, luka
bakar, dan bekas gigitan



Berdasarkan Kondisi Luka

Luka Terbuka

Contoh:
Luka tembus, luka
diabetes, dan luka
bakar



Luka Tertutup

Contoh:
Luka memar,
Hematoma, ulkus
dekubitus



Berdasarkan Tingkat Kontaminasi

Luka Bersih

Luka karena tindakan operasi dengan teknik steril

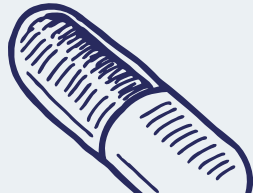


Luka Kontaminasi

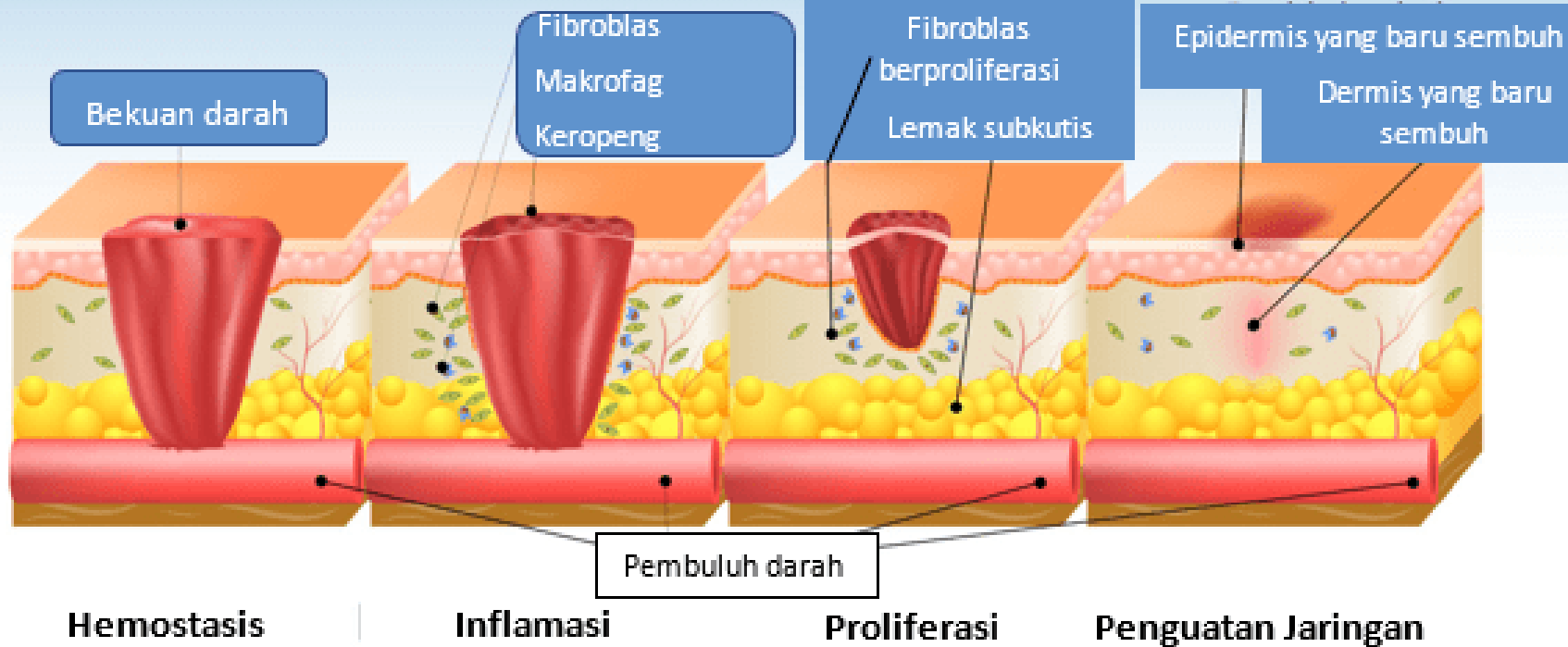
Luka karena lingkungan kotor sehingga menjadi luka infeksi



Proses Penyembuhan Luka



TAHAPAN PENYEMBUHAN LUKA





Tahap Penyembuhan Luka



Hari ke 0-5 terjadi **proses pembekuan darah** untuk mencegah kehilangan darah. Karakteristik: tumor, rubor, dolor, color, functio laesa. Fase awal terjadi homeostasis, fase akhir fagositosis.



1. Fase Inflamasi

Fase **pembentukan jaringan granulasi pada luka** terjadi dalam 24 jam pertama dengan penebalan epidermis tepian luka. Karakteristik: luka nampak merah segar, mengkilat



2. Fase Proliferasi





Tahap Penyembuhan Luka



Berlangsung beberapa minggu sampai 2 tahun.
Terbentuknya kolagen baru dan peningkatan kekuatan jaringan, jaringan parut.



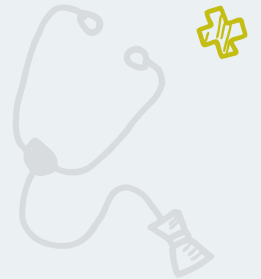
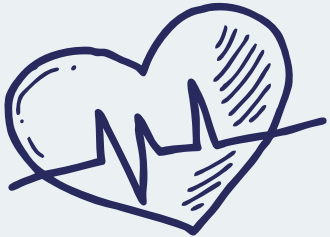
3. Fase Maturasi

Usia, infeksi, hipovolemia, hematoma, benda asing, iskemia, diabetes, dan pengobatan steroid

Faktor yang memengaruhi penyembuhan luka



Perawatan Luka



Jenis Perawatan Luka



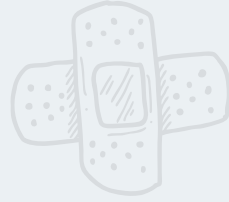
Conventional Dressing

Pembalutan luka dengan prinsip kering menggunakan kassa dan perban

Modern Dressing

Metode perawatan luka dengan moist wound healing, yaitu prinsip lembab untuk pemulihan luka. Tujuan: mencegah dehidrasi luka





Perawatan Luka Bersih

Perawatan luka **bertujuan untuk meningkatkan proses penyembuhan jaringan juga mencegah infeksi**. Perawatan luka bersih contohnya pada luka operasi. Perawatan luka harus memperhatikan **teknik steril**, karena luka menjadi pintu masuk mikroorganisme yang dapat menginfeksi luka.



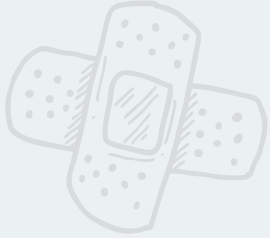
Persiapan Alat

Bak Instrumen

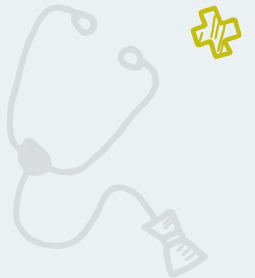
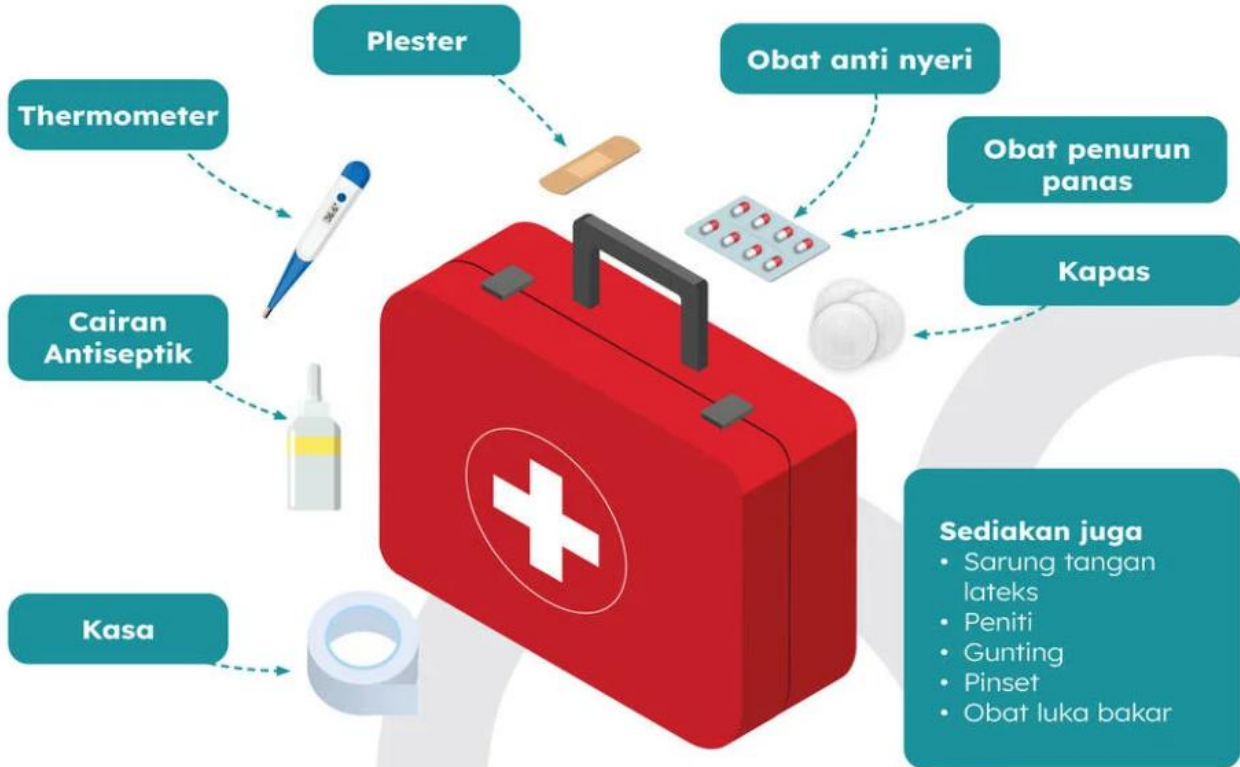
- Pinset anatomis
- Pinset chirugis
- ✚ ○ Gunting debridemand
- Kassa steril
- Kom

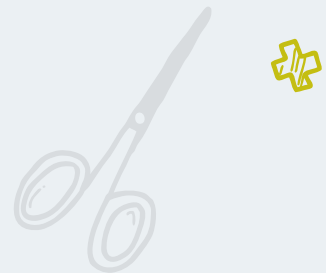
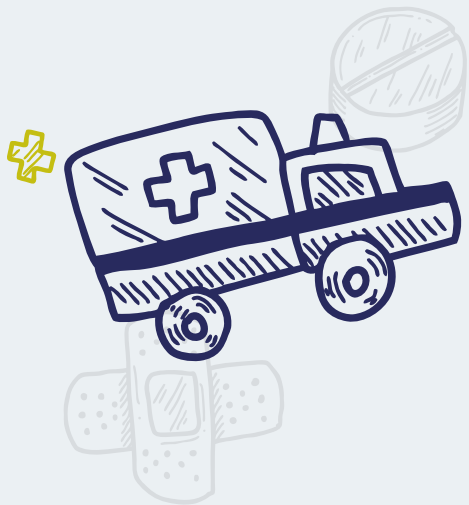
Peralatan Lain

- Sarung tangan
- Gunting plester
- Plester
- Alkohol
- Desinfektan
- NaCl
- Bengkok
- Perban
- Obat sesuai kebutuhan



Isi Kotak P3K Perawatan Luka di Rumah





Terima Kasih



Perawatan Luka Jahit

Ns. Eka Diana Permatasari



Luka Jahit





Luka Jahit?

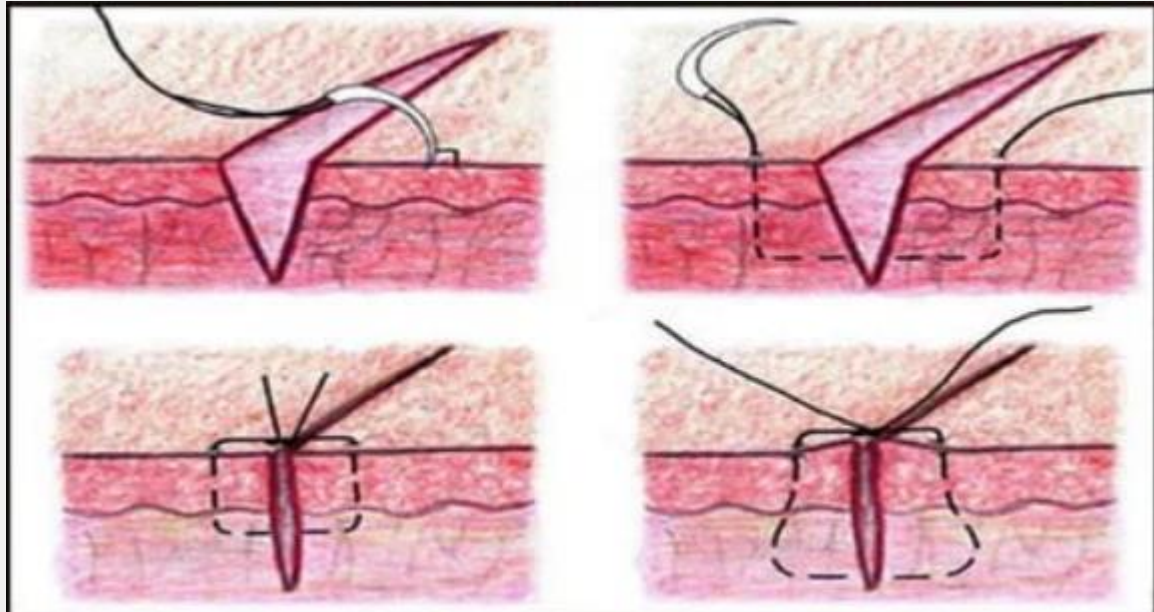
Luka yang mengakibatkan rusaknya jaringan epidermis kulit beserta jaringan di bawahnya yang cukup dalam perlu dilakukan prosedur jahit luka untuk menghindari keparahan luka dan infeksi.

Jenis Jahitan Luka

JAHITAN SIMPUL TUNGGAL

Disebut dengan **jahitan terputus sederhana**

Caranya dengan melakukan penusukan jarum dengan jarak antara 0,5-1 cm di tepi luka sekaligus mengambil jaringan subkutan kemudian menusukkan jarum tegak lurus searah garis luka



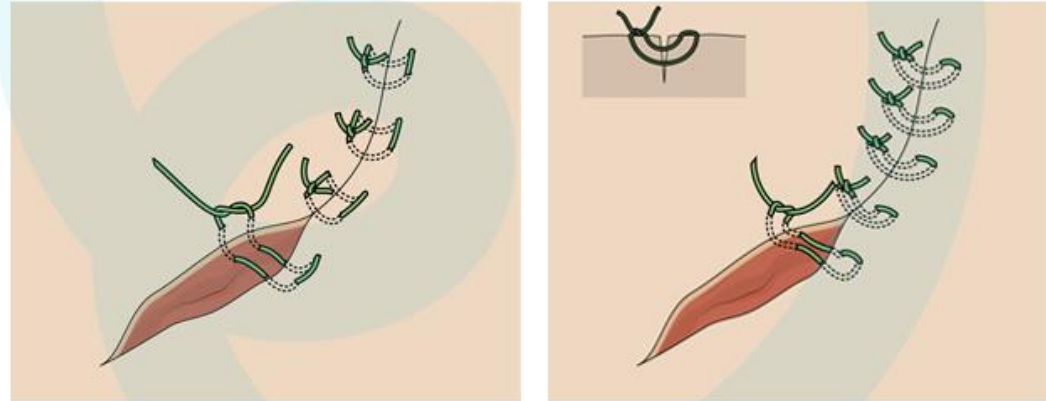
Jenis Jahitan Luka

JAHITAN MATRAS VERTIKAL

Jahitan dengan menjahit secara **mendalam di bawah luka kemudian dilanjutkan dengan menjahit tepi-tepi luka**. Biasanya menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini

JAHITAN MATRAS HORIZONTAL

Jahitan dengan melakukan penusukan seperti simpul, sebelum disimpul dilanjutkan dengan penusukan sejajar sejauh 1 cm dari tusukan pertama. Memberikan hasil jahitan yang kuat.



Sumber: Wikipedia

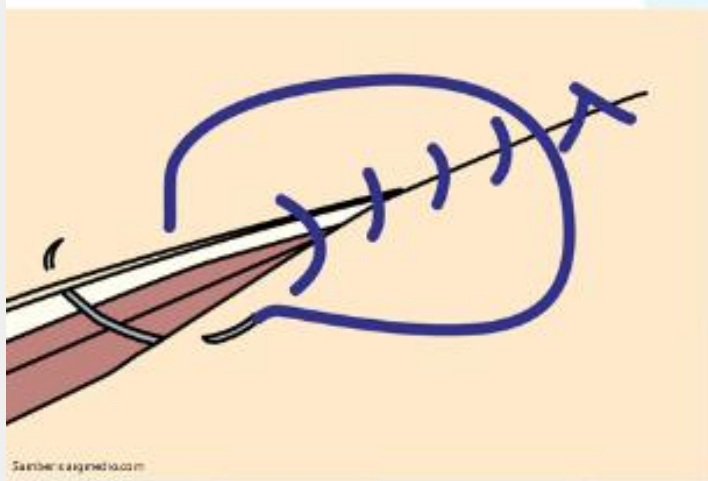
Gambar 5. Jahitan Matras Horizontal (Kiri) dan Vertikal (Kanan)



Jenis Jahitan Luka

JAHITAN JELUJUR SEDERHANA

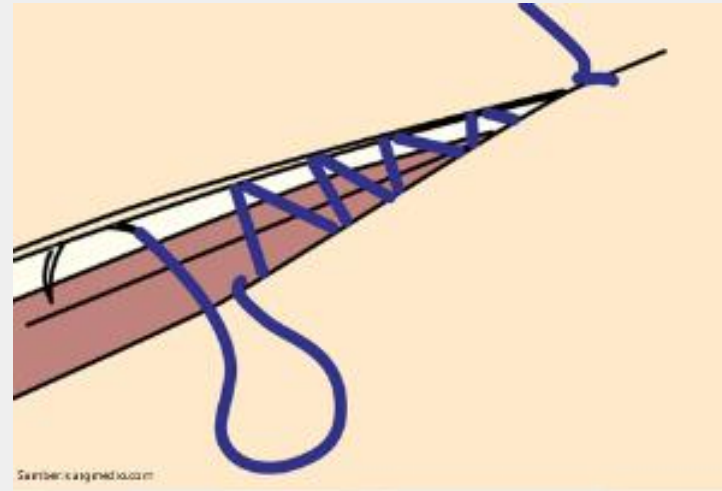
Jahitan ini sangat sederhana seperti menjelujur baju. Kekurangan teknik ini yaitu terdapat risiko bekas jahitan dan dehiscence



Gambar 3. Jahitan Simple Continuous

JAHITAN JELUJUR INTRAKUTAN

Jahitan jelujur yang dilakukan dibawah kulit, jahitan ini terkenal menghasilkan kosmetik yang baik



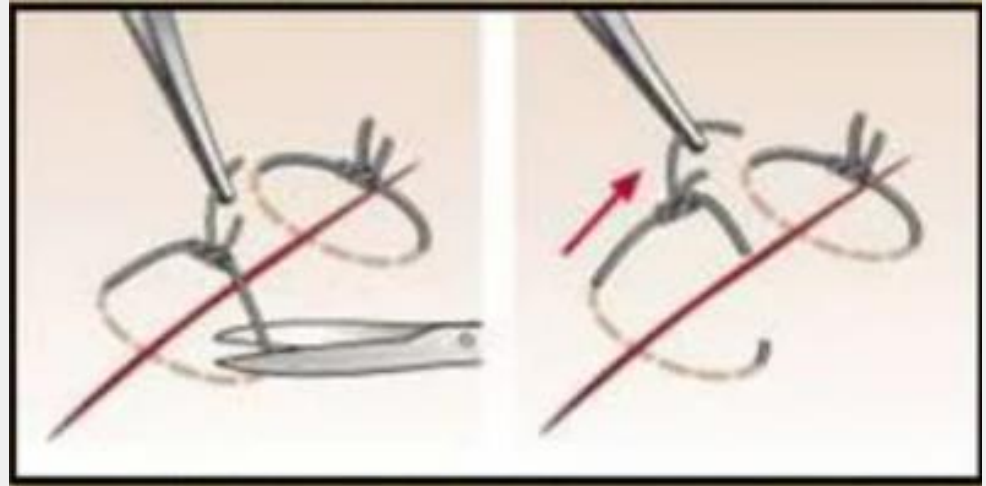
Gambar 4. Jahitan Subcuticular Continuous

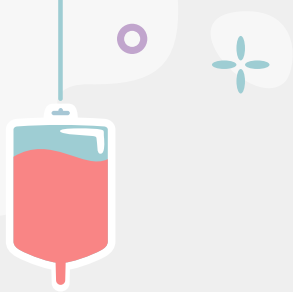


ANGKAT JAHITAN

Proses pengambilan benang pada luka berdasarkan lokasi dan hari tindakan:

- a. Muka atau leher hari ke 5
- b. Perut hari ke 7-10
- c. Telapak tangan 10
- d. Jari tangan hari ke 10
- e. Tungkai atas hari ke 10
- f. Tungkai bawah 10-14
- g. Dada hari ke 7
- h. Punggung hari ke 10-14





Komplikasi Jahitan Luka

- Hematoma karena hemostasis yang kurang adekuat pada daerah luka
- Infeksi
- Dehiscence apabila aproksimasi jahitan kurang tepat
- Terbentuknya jaringan parut
- Hipertrofi pada jaringan parut/keloid



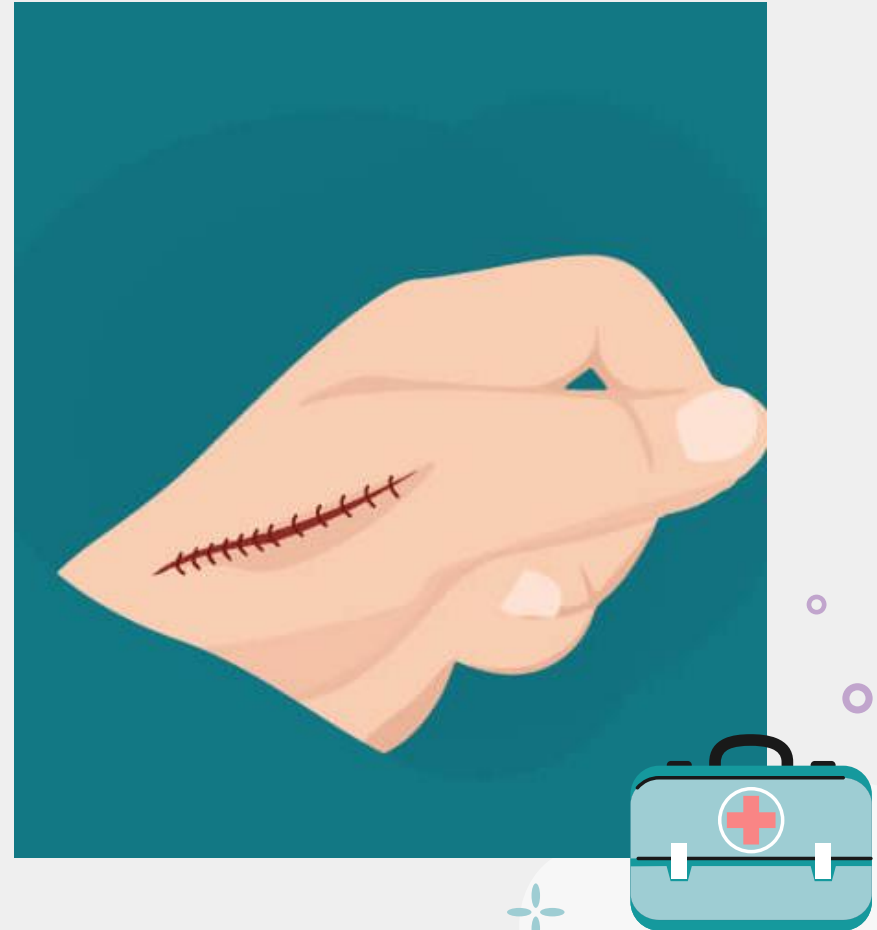
Indikasi Perawatan Luka

1. Menjaga kebersihan dan mencegah infeksi
2. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien
3. Mempercepat proses penyembuhan luka
4. Mencegah bertambahnya kerusakan jaringan
5. Mempermudah keluarnya cairan yang keluar dari luka
6. Mencegah perdarahan di sekitar luka



Karakteristik Luka Jahit

- Lokasi luka
- Bentuk luka
- Ukuran luka
- Kedalaman luka
- Undermining/tunneling
- Karakteristik jaringan nekrotik
- Eksudat
- Warna kulit di sekitar luka
- Edema





Tanda-tanda Infeksi

- Rubor (kemerahan): terjadi pada area yang mengalami infeksi
- Kalor (panas): pada daerah yang mengalami infeksi akan terasa panas
- Tumor (bengkak): Pembengkakan pada sekitar luka yang mengalami infeksi
- Dolor (nyeri): Pada daerah luka yang mengalami infeksi terasa nyeri
- Fungsio laesa (perubahan fungsi jaringan) yang mengalami infeksi



